Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Estratégias, Acreditação e Componentes da Atenção Primária à Saúde

NOTA TÉCNICA Nº 12/2026-DEAPS/SAPS/MS

1. ASSUNTO

1.1. Esta Nota Técnica tem por objetivo apresentar a metodologia de cálculo do desempenho quadrimestral do **Componente III – Qualidade**, previsto na Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, e na Portaria GM/MS nº 7.799, de 20 de agosto de 2025, especificamente para as equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), equipes de Consultório na Rua (eCR) e equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP), para fins de cofinanciamento federal da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1. A Nota Técnica nº 8/2026-DEAPS/SAPS/MS (0055690090) apresenta, para as equipes de Saúde da Família (eSF), equipes de Saúde Bucal (eSB) e equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde (eMulti), a metodologia de apuração quadrimestral do **Componente III - Qualidade**, incluindo o cálculo da nota final, a conversão dos conceitos dos indicadores em pontuação e as faixas de classificação para definição do incentivo financeiro.

2.2. Aos moldes das tipologias supracitadas, as equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), equipes de Consultório na Rua (eCR) e equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) seguirão metodologia de apuração quadrimestral do **Componente III - Qualidade** aqui estabelecida, com especificação, a seguir, dos conceitos, da pontuação e das faixas de classificação para definição do incentivo financeiro.

2.3. Os resultados mensais dos indicadores serão utilizados para a apuração do resultado quadrimestral, conforme a metodologia descrita nesta Nota Técnica e nas respectivas fichas técnicas dos indicadores.

3. COMPONENTE III: QUALIDADE DO CUIDADO

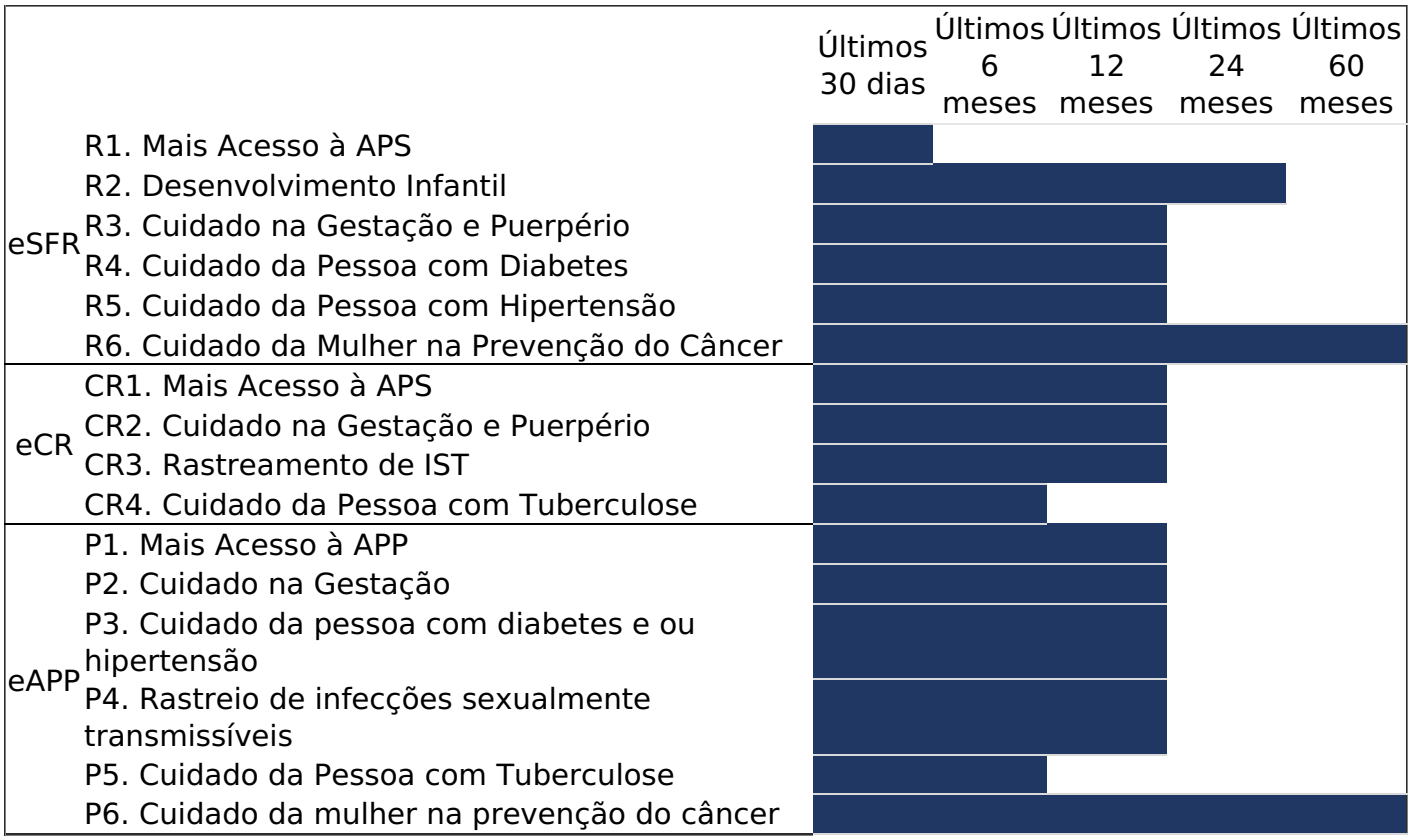
3.1. O resultado quadrimestral de cada indicador será obtido pela média dos resultados mensais válidos no quadrimestre avaliado, observadas as regras constantes da respectiva ficha técnica.

3.1.1. Em caso de suspensão de pagamento, a média será aplicada sobre os meses válidos para pagamento.

Atenção: Para os indicadores do cuidado no Desenvolvimento Infantil e na Gestação e Puerpério, o resultado quadrimestral levará em consideração apenas os meses que possuam crianças que completaram dois anos e gestações que atingiram o 42° dia de puerpério no período em avaliação.

3.2. Os resultados de cada indicador serão analisados conforme o período de monitoramento, ilustrado a seguir:

Figura 1. Período máximo de monitoramento das Boas Práticas



3.3. **Nota Final do Componente III - Qualidade**

3.3.1. Para obter-se a Nota Final do Componente III, serão somados pontos por indicador ponderado pelo peso atribuído, conforme exemplo abaixo:

Quadro 1. Cálculo ilustrativo do Resultado do Quadrimestre por Indicador para uma equipe

Indicador	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Resultado do Quadrimestre	Conceito Obtido
R1. Mais Acesso à APS	42,62%	40,87%	41,9%	51,98%	44,34%	Bom
R2. Desenvolvimento Infantil *	80%	-	85%	-	81,3%*	Ótimo
R3. Cuidado na Gestação e Puerpério *	75%	-	-	-	75%*	Ótimo
R4. Cuidado da Pessoa com Diabetes	45,2%	43,9%	49,8%	49,9%	47,2%	Suficiente
R5. Cuidado da Pessoa com Hipertensão	10%	11%	10%	50%	20,25%	Regular
R6. Cuidado da Mulher na Prevenção do Câncer	90%	84%	81%	79%	83,5%	Ótimo

Nota: * O sinal " - " neste exemplo significa que a equipe em questão não possui crianças completando 2 (dois) anos de idade e que a equipe em questão não possui gestações encerrando o puerpério em todos os meses do período.

3.3.2. Assim, para cálculo da pontuação final, cada conceito obtido no indicador equivale a pontuação abaixo:

Quadro 2. Pontuação para cada conceito do indicador

Conceito no Indicador
Regular: 0,25
Suficiente: 0,50
Bom: 0,75
Ótimo: 1,00

3.3.3. As eSFR, eCR e eAPP, seguirão a mesma metodologia nos seus indicadores, observados os pesos dos quadros 3, 4 e 5.

Quadro 3. Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)

Cálculo			**Atenção: Exemplo**	
Indicador (A)	**Peso (B)**	**Nota por Indicador**	**Conceito obtido na Média**	**Nota**
R1. Mais Acesso à APS	1	A x B = Nota R1	Bom	0,75 x 1 = 0,75
R2. Desenvolvimento Infantil	2	A x B = Nota R2	Ótimo	1 x 2 = 2
R3. Cuidado na Gestação e Puerpério	2	A x B = Nota R3	Ótimo	1 x 2 = 2
R4. Cuidado da Pessoa com Diabetes	1,5	A x B = Nota R4	Suficiente	0,5 x 1,5 = 0,75
R5. Cuidado da Pessoa com Hipertensão	1,5	A x B = Nota R5	Regular	0,25 x 1,5 = 0,375
R6. Cuidado da Mulher na Prevenção do Câncer	2	A x B = Nota R6	Ótimo	1 x 2 = 2
Total	**10**	**Nota Final**		**7,875**

Quadro 4. Equipes de Consultório na Rua (eCR)

Cálculo			**Atenção: Exemplo**	
Indicador (A)	**Peso (B)**	**Nota por Indicador**	**Conceito obtido na Média**	**Nota**
CR1. Mais Acesso à APS	2	A x B = Nota CR1	Bom	0,75 x 2 = 1,5
CR2. Cuidado na Gestação e Puerpério	2	A x B = Nota CR2	Ótimo	1 x 2 = 2
CR3. Rastreamento de IST	3	A x B = Nota CR3	Ótimo	1 x 3 = 3
CR4. Cuidado da Pessoa com Tuberculose	3	A x B = Nota CR4	Suficiente	0,5 x 3 = 1,5
Total	**10**	**Nota Final**		**8**

Quadro 5. Equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP)

Cálculo			Atenção: Exemplo	
Indicador (A)	**Peso (B)**	**Nota por Indicador**	**Conceito obtido na Média**	**Nota**
P1. Mais acesso à Atenção Primária Prisional	1	A x B = Nota P1	Bom	0,75 x 1 = 0,75
P2. Cuidado na Gestação *	1	A x B = Nota P2	Ótimo	1 x 1 = 1
P3. Cuidado da pessoa com diabetes e ou hipertensão	1	A x B = Nota P3	Regular	0,25 x 1 = 0,25
P4. Rastreio de infecções sexualmente transmissíveis	3	A x B = Nota P4	Bom	0,75 x 3 = 2,25
P5. Cuidado da Pessoa com Tuberculose	3	A x B = Nota P5	Ótimo	1 x 3 = 3
P6. Cuidado da mulher na prevenção do câncer *	1	A x B = Nota P6	Ótimo	1 x 1 = 1
Total	**10**	**Nota Final**		**8,25**

Nota: * Para os indicadores **P2 – Cuidado na Gestação** e **P6 – Cuidado da Mulher na Prevenção do Câncer**, quando a equipe de Atenção Primária Prisional (eAPP) estiver vinculada exclusivamente a unidade prisional sem população feminina ou sem gestantes elegíveis para acompanhamento, será atribuída a pontuação integral do respectivo indicador, não havendo prejuízo à composição da nota final do Componente III – Qualidade.

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. Para definição do valor do incentivo financeiro a ser transferido, as Notas Finais do Componente III serão classificadas conforme os intervalos abaixo:

Quadro 6. Classificação para o Incentivo Financeiro conforme a Nota Final do Componente III

Nota Final Componente III	Classificação para o Incentivo Financeiro
> 7,5	Ótimo
≥ 5 e ≤ 7,5	Bom
> 2,5 e < 5	Suficiente
≤ 2,5	Regular

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024**. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)**.** Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt3493_11_04_2024.html .

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 6.907, de 29 de abril de 2025**. Altera dispositivos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, da Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, e revoga dispositivos da Portaria Saps/MS nº 161, de 10 de dezembro de 2024, e da Portaria GM/MS nº 5.668, de 1º de novembro de 2024, que dispõem sobre a metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde - APS no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília:

Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2025/prt6907_08_05_2025.html .

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 7.639, de 18 de julho de 2025**. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2025/prt7639_22_07_2025.html .

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 7.799, de 20 de agosto de 2025**. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017 e a Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, bem como revoga a Portaria GM/MS nº 5.668, de 1º de novembro de 2024, para dispor sobre a metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde - APS no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e o incentivo financeiro federal de custeio das equipes de Consultório na Rua - eCR e equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP, e dispor sobre os eixos temáticos do componente de qualidade para as equipes de Saúde da Família Ribeirinha - eSFR. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2025/prt7799_21_08_2025.html .

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Metodológica de Vínculo e Acompanhamento Territorial**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notastecnicas/2024/nota-metodologica.pdf .

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Portaria SAPS/MS nº 161, de 10 de dezembro de 2024**. Estabelece a metodologia de cálculo do Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial para as equipes de Saúde da Família - eSF, equipes de Atenção Primária - eAP, e as equipes vinculadas em conformidade com o Título II da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://sisaps.saude.gov.br/sistemas/sisab/assets/files/portaria-N161-10dezembro-2024-metodologia-componente-II-53193c899c28ff8da0d0446fe61fa8c5.pdf .

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Portaria de Consolidação nº 1 SAPS/MS, de 2 de junho de 2021.** Consolidação das normas sobre Atenção Primária à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/saps/2021/prc0001_08_06_2021.html .

Documento assinado eletronicamente por **Ethel Proenca Braga**, **Coordenador(a)-Geral de Acesso e Equidade na Atenção Primária à Saúde substituto(a)**, em 29/09/2026, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **José Eudes Barroso Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Saúde da Família**, em 29/09/2026, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Audrey Fischer**, **Diretor(a) do Departamento de Estratégias, Acreditação e Componentes da Atenção Primária à Saúde**, em 29/09/2026, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas**, **Secretário(a) de Atenção Primária à Saúde**, em 29/09/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0058381406** e o código CRC **A0620F11**.